ECIRS

U wordt binnenkort opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie voor een Endoscopic Combined IntraRenal Surgery (ECIRS) ter behandeling van een niersteen.

Deze brochure wil u informeren over de geplande ingreep en wegwijs maken in het verloop van uw opname. Hebt u nog bijkomende vragen, dan kan u hiervoor uiteraard terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundige.

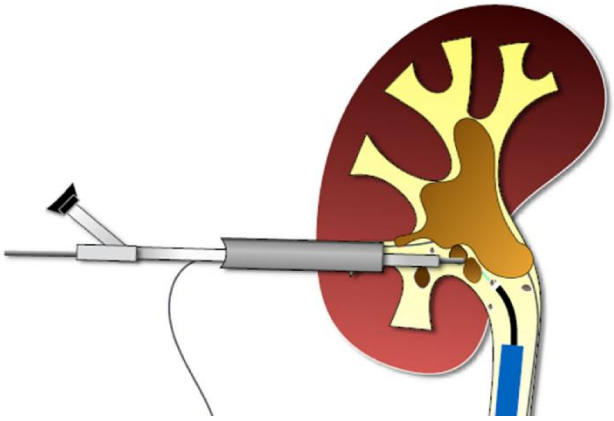
Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

1. ECIRS

Een ECIRS is een kijkoperatie om nierstenen te verwijderen. De afkorting staat voor Endoscopic Combined IntraRenal Surgery, wat betekent dat de ingreep via twee toegangswegen tegelijk gebeurt:

- via de urineleider met een dunne flexibele camera (ureterorenoscoop),
- via een kleine opening in de flank (percutane toegang).

Door deze combinatie kan de arts de steen zowel van binnenuit als rechtstreeks vanuit de nier benaderen, wat toelaat om grotere of moeilijk bereikbare stenen efficiënter te verwijderen.



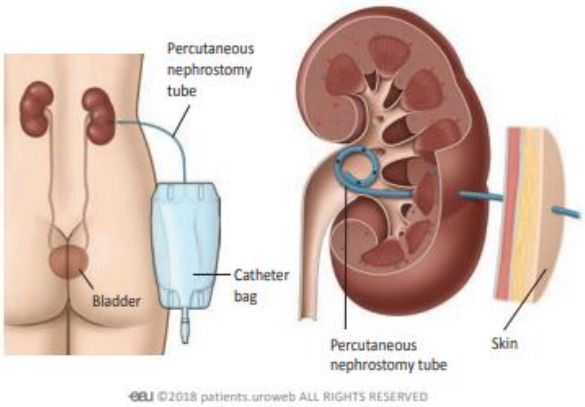
ECIRS: Adapted from Inoue T et al., Int J Urol 2018;25:121–133.

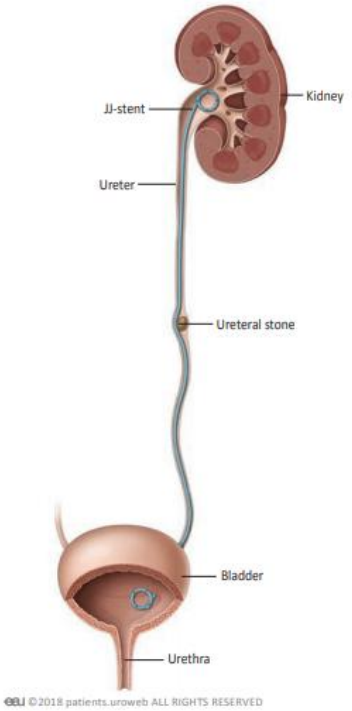
Een ECIRS gebeurt onder volledige verdoving (algemene narcose). De uroloog benadert de niersteen dus op 2 manieren: via de plasbuis tot in de nier met een dunne camera en tegelijk via een kleine toegang in de flank waardoor een 2e camera en werkinstrumenten worden ingebracht. De stenen worden bijgevolg in kleine fragmenten vergruisd en verwijderd. Het voordeel van deze aanpak is de hogere kans op volledige steenverwijdering in één behandelingstijd alsook minder weefselschade ter hoogte van de urineleider.

Op het einde van de ingreep wordt ingeschat of een dubbel J-stent (DJ-stent) dient nagelaten te worden. Deze stent zorgt ervoor dat de urineleider wordt opengehouden en er geen belemmering is in de afvloei van urine door steenfragmenten of zwelling van de urineleider. De beslissing of er al dan niet zo een stent wordt nagelaten, hangt af van verschillende factoren: hoe vlot de steen verwijderd kon worden, of er nog een 2e operatietijd noodzakelijk is en hoe de urineleider zich presenteert op het einde van de ingreep.

Het verwijderen van de stent gebeurt doorgaans 2 weken na de ingreep, onder lokale verdoving op de controle consultatie. Indien een heringreep noodzakelijk is, blijft de stent behouden tot het volgende operatiemoment.

In sommige situaties wordt tijdelijk een nefrostomie katheter nagelaten in de rechtstreekse toegang van de flank naar de nier. Deze blijft doorgaans maar enkele dagen behouden en wordt meestal verwijderd vooraleer u naar huis vertrekt.





2. Complicaties

Elke operatie houdt bepaalde risico's in. Bij een ureterorenoscopie zijn de meest voorkomende:

- **Urineweginfectie:**
  Voor de ingreep wordt uw urine gecontroleerd op bacteriën. Indien nodig start u enkele dagen op voorhand met antibiotica. Tijdens de ingreep krijgt u bovendien preventief antibiotica toegediend via een infuus. Toch kan er na de ingreep een infectie optreden. Dit merkt u meestal zelf door het ontstaan van koorts, koude rillingen of een algemeen ziek gevoel.
- **Beschadiging van de urineleider:**
  Wanneer een steen langdurig vastzit of bij het veelvuldig inbrengen van instrumenten via de urineleider kan de wand van de urineleider beschadigd raken. Dit geneest meestal vanzelf, maar in zeldzame gevallen kan er op langere termijn een vernauwing (*strictuur*) ontstaan.
- **Bloed in de urine:**
  De aanwezigheid van bloed in de urine komt vaak voor na deze ingreep en verdwijnt meestal spontaan. Wanneer een DJ-stent geplaatst wordt, kan het bloedverlies aanhouden zolang de stent aanwezig is.
- **Pijnklachten:**
  Na de ingreep kunt u wat pijn of een branderig gevoel ervaren bij het plassen. Ook een zeurende pijn in de flank of blaasregio komt geregeld voor, zeker als er een DJ-stent geplaatst werd. De minimale incisie ter hoogte van de flank kan eveneens gevoelig zijn. Dit verdwijnt meestal geleidelijk en kan goed behandeld worden met pijnstillers zoals paracetamol.
- **Koorts of algemeen onwel gevoel:**
  Een beperkte temperatuursverhoging kort na de ingreep is niet ongewoon. Blijft de koorts aanhouden of stijgt ze boven 38°C, contacteer dan uw arts. Dit kan wijzen op een infectie die bijkomende behandeling vereist.
- **Nood aan heringreep:**
  In sommige gevallen kunnen kleine steendeeltjes achterblijven of kan de steen niet volledig verwijderd worden. Dan kan een tweede behandeling nodig zijn.

- **Lekken van urine via de wonde in de rug:** gezien de toegang tot de nier in de flank niet gesloten kan worden, kan er tijdelijk wat urinelekkage optreden. Dit is meestal tijdelijk en verdwijnt zodra de nefrostomie katheter verwijderd wordt.
- **Letsel aan omliggende organen:** zeer uitzonderlijk kan er schade ontstaan aan nabijgelegen structuren (zoals darmen, bloedvaten of milt), vooral bij afwijkende anatomie of littekenweefsel.

3. Voorbereiding

Preoperatieve consultatie (POC)

Sommige patiënten worden best voorgaand aan de ingreep gezien door de anesthesist (indien je > 70j bent, belangrijke medische voorgeschiedenis hebt, BMI > 35 hebt, of indien je 5 of meer geneesmiddelen neemt). Zij bekijken samen met u welke preoperatieve onderzoeken noodzakelijk zijn: bvb ECG of bloedafname. Of u bij de anesthesist dient langs te gaan, wordt besproken op de consultatie met uw behandelend Uroloog.

Urinestaal

Minstens 2-3 weken voor de ingreep dient een urinestaal via uw huisarts/ziekenhuis te worden binnengebracht om infectie na te gaan. In geval van infectie zullen wij u contacteren en antibiotica opstarten.

Medicatie

Bloedverdunners dienen meestal tijdelijk gestaakt te worden. Bespreek dit met uw behandelend Uroloog.

Antibiotica wordt voorafgaand aan de ingreep opgestart op advies van uw behandelend Uroloog in functie van een afwijkend urinestaal. Dit wordt telefonisch met u besproken, zorg dat wij steeds een geldig telefoonnummer van u in ons dossier hebben staan door dit via ons secretariaat door te geven.

Vergeet zeker niet uw thuismedicatie mee te brengen bij de opname. Bij voorkeur in de originele verpakking.

Uur van ingreep

Twee werkdagen voor de geplande operatiedatum wordt u telefonisch gecontacteerd om door te geven om welk uur u verwacht wordt in het ziekenhuis. Dit wordt afgestemd op het richt uur van de operatie maar is geen bevestiging van een bepaald uur, pin u dus niet per se vast op dit moment.

4. Opname op de hospitalisatieafdeling

Voor deze ingreep wordt u opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie omdat u één nacht in het ziekenhuis moet blijven. U brengt dus nachtkledij, toilet- en wasgerief mee. Een paar pantoffels en eventueel een kamerjas zijn handig. Als u anti-emboliekousen (= TED-kousen) hebt van een eerdere operatie, breng die dan ook mee.

De verpleegkundige of secretaresse van de hospitalisatieafdeling zal u verwelkomen en u naar uw kamer begeleiden. De verpleegkundige stelt u nog enkele vragen om de zorg op u af te stemmen. Het uur waarop de ingreep vermoedelijk zal doorgaan, wordt u meegedeeld.

Omwille van de verdoving die u zal krijgen, mag u vanaf middernacht voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.

Ter voorbereiding op de ingreep vragen wij u aandacht te besteden aan een goede intieme hygiëne.

5. Moment van de ingreep

Op het ogenblik dat uw arts u naar de operatiezaal vraagt, zal de verpleegkundige u een operatiehemdje geven om aan te trekken. U trekt dan alle andere kledij uit, net zoals juwelen, kunstgebit, hoorapparaat of bril. De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de bedhold (wachtzaal voor patiënten die geopereerd zullen worden).

Voordat u in slaap wordt gebracht, zal de Anesthesist u nog enkele vragen stellen. Het is mogelijk dat u uw Uroloog niet meer zal zien vlak voor u in slaap gaat, omdat hij pas binnenkomt als u al slaapt.

De ingreep duurt doorgaans 1- 2 uren.

6. Na de ingreep

Opname post-anesthesie zorgafdeling (PAZA)

Na de ingreep gaat u naar de PAZA of ontwaakzaal. Hier wordt u tijdens het ontwaken uit de verdoving strikt opgevolgd door de verpleegkundigen en de Anesthesist. U zal verbonden zijn met een monitor waarop uw bloeddruk, pols en ademhaling gevolgd worden. De verpleegkundigen geven u ook de voorgeschreven pijnstilling.

Na de ingreep hebt u ook een blaassonde doorheen uw plasbuis tot in de blaas. Dit is een soepel hol buisje, waarlangs de urine afloopt in een urinezak. Het hebben van een sonde is niet pijnlijk maar kan als onaangenaam ervaren worden.

Wanneer de Anesthesist beslist dat het veilig is om u terug naar de hospitalisatieafdeling te brengen, zullen de verpleegkundigen u komen halen en terugbrengen. Het is best mogelijk dat u zich achteraf niet alles meer herinnert van het verblijf op de PAZA.

Terug op de kamer

Doorgaans blijft u 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis. Na de ingreep zal u een blaassonde en mogelijks DJ-stent hebben. De blaassonde wordt daags na de ingreep verwijderd.

Na het verwijderen van de sonde zal de verpleegkundige uw plas opvolgen. Het is best mogelijk dat het plassen na de ingreep branderig aanvoelt. Dit is normaal en kan tot 24u na het verwijderen van de sonde voorkomen.

7. Ontslag

Op basis van uw pijnklachten en het verloop van de ingreep, beslist de arts wanneer u naar huis kan gaan. Voordat u naar huis gaat, krijgt u van de secretaresse of verpleegkundige een controleafspraak om terug te keren naar uw Uroloog.

8. Nazorg en verwachtingen thuis

Het herstel na een ECIRS verloopt doorgaans vlot maar enkele ongemakken kunnen thuis wel nog voorkomen. Het kan zijn dat u gedurende enkele dagen lichte pijn of branderigheid ervaart bij het plassen. Er kan nog enkele dagen wat bloed in de urine zitten, hetgeen normaal is en spontaan verdwijnt.

Drink voldoende water (minstens 1.5 – 2 liter per dag) om de urinewegen te spoelen en neem de voorgeschreven pijnstilling en/of antibiotica zoals aangegeven.

Indien er tijdens de ingreep een DJ-stent werd geplaatst, kan u tijdelijk volgende symptomen ervaren: frequenter urineren, drukkend gevoel in blaas of flank, bloed in de urine, lichte pijn bij het plassen of blaaskrampen. Deze klachten verdwijnen na verwijderen van de stent. Indien deze klachten onvoldoende te controleren zijn met klassieke pijnstilling, kan iom uw behandelend Uroloog bijkomende medicatie worden opgestart, namelijk anticholinergica (bvb solifenacine of oxybutynine) of een β-3-adrenoceptor-agonist (bvb vibegron of mirabegron).

De hechtingen ter hoogte van de flank zijn zelfverterend en dienen dus niet verwijderd te worden. U kan vanaf de eerste dag na de operatie douchen. Het nemen van een bad of zwemmen dient gedurende 2 weken vermeden te worden.

9. Alarmtekens

Alertheid voor eventuele complicaties is belangrijk. In volgende situaties raden wij aan uw Uroloog te contacteren of zich te melden via Spoedgevallen:

- Koorts boven de 38.5°C of koude rillingen
- Ernstige onderbuikspijn die met klassieke pijnstilling of de voorgeschreven medicatie niet onder controle geraakt
- Uitgesproken bloed in de urine met bloedklonters
- Onmogelijkheid te urineren of erg pijnlijke gevoel bij het plassen.

⇨ Indien u twijfelt over uw symptomen kan u altijd contact opnemen met de dienst Urologie.

10. Checklist: wat breng ik mee bij een opname?

- Thuismedicatie, bij voorkeur in de originele verpakking. Inclusief eventuele antibiotica of bloedverdunners.
- TED-kousen zo u dit heeft
- GSM en oplader
- Eventuele vragenlijsten of papieren die u nog waren gevraagd in te vullen
- Verzekeringspapieren die dienen getekend te worden door de arts

11. Vragen? Noteer ze hieronder.

12. Contact

Hospitalisatieafdeling Urologie

Tel. 09 332 27 61

Polikliniek Urologie
Tel. 09 332 22 76

Link naar ingreep: https://youtu.be/D6vO2ASsQaU